· 论　　著 ·

晚期癌症患者家庭沟通现状及影响因素分析

马瑞瑞　范晓莉　陶秀彬　张伟　陈婷

（皖南医学院附属弋矶山医院，安徽 芜湖 241000）

摘　要　目的 了解晚期癌症患者家庭沟通现状并探究其影响因素。**方法** 2023 年 9 月—2024 年 6 月，采用便利抽样法抽取安徽省 2 所三级甲等综合医院的 200 例晚期癌症患者为研究对象，采用一般资料调查表、癌症患者家庭沟通量表-患者版（the cancer communication assessment tool for patients and families-patients，CCAT-P）、家庭功能评估量表（the adaptation partnership growth affection and resolve，APGAR）、恐惧疾病进展简化量表（fear of progression questionnaire-short form，FoP-Q-SF）、癌症患者社会疏离量表（social isolation assessment questionnaire for cancer patients，SIAQ-CP）进行调查，采用单因素和多因素 logistic 回归分析晚期癌症患者家庭沟通的影响因素。**结果** 共 108 例（54.0%）晚期癌症患者存在家庭沟通障碍。logistic 回归分析结果显示，文化程度、家庭人均月收入、确诊时长、家庭功能、恐惧疾病进展、社会疏离是晚期癌症患者家庭沟通的独立影响因素（$P<0.05$）。**结论** 晚期癌症患者家庭沟通水平处于沟通不良状态。临床医护人员需重点关注存在家庭功能障碍、伴有恐惧疾病进展、社会疏离程度高、文化程度较低、确诊时长≥1 年、家庭人均月收入水平低的晚期癌症患者家庭。针对此类家庭，建议制定并实施个体化的临床干预方案，通过提升家庭内部积极沟通水平，进而改善晚期癌症患者生命质量。

关键词　晚期癌症；　家庭照顾者；　家庭沟通；　影响因素；　护理

Current situation and influencing factors of family communication among advanced cancer patients

MA Ruirui，FAN Xiaoli，TAO Xiubin，ZHANG Wei，CHEN Ting

（*Wannan Medical University Affiliated Yijishan Hospital*，*Wuhu 241000*，*Anhui*，*China*）

Abstract　Objective To understand the current status of family communication among patients with advanced cancer and explore its influencing factors. **Methods** From September 2023 to June 2024，200 patients with advanced cancer from 2 Class Ⅲ Grade A general hospitals in Anhui province were selected as study subjects by a convenience sampling method，and were investigated by a general information questionnaire，the cancer communication assessment tool for patients and families -patients（CCAT-P），the adaptation partnership growth affection and resolve（APGAR），fear of progression questionnaire-short form（FoP-Q-SF），and social isolation assessment questionnaire for cancer patients（SIAQ-CP）. Univariate and multivariate logistic regression analyses were used to analyze the influencing factors of family communication in patients with advanced cancer. **Results** A total of 108 patients（54.0%）with advanced cancer experienced communication barriers within their families. The results of logistic regression analysis showed that education level，family monthly income per capita，duration since diagnosis，family function，fear of disease progression，and social alienation are independent influencing factors of family communication in patients with advanced cancer（$P<0.05$）. **Conclusion** The level of family communication in advanced cancer patients is in a poor state. Clinical healthcare professionals should pay close attention to families of advanced cancer patients who experience family dysfunction，fear of disease progression，high degree of social isolation，low educational level，duration of diagnosis≥1 year，and a low average monthly household income per capita. For such families，it is recommended to develop and implement individualized clinical intervention plans aimed at improving the quality of life of advanced cancer patients by enhancing the level of positive communication within the family.

Keywords　advanced cancer；　family caregiver；　family communication；　influencing factors；　nursing

中图分类号：R473.73，R48　　**文献标识码**：A　　**DOI**：10.16821/j.cnki.hsjx.2025.21.008

基金项目：安徽省省级课程思政示范课程《护理实验学》（编号：2021kcszsfkc433）；安徽省教育厅自然科学重点项目（编号：KY22040046）

作者简介：马瑞瑞（1995－），女，安徽芜湖，硕士，研究方向：安宁疗护，急危重症护理，心理护理

通信作者：范晓莉，Email：19631243@qq.com

中国知网　https://www.cnki.net

癌症目前是全球最主要的公共卫生问题,预计将会成为全球主要死亡原因之一的疾病[1]。国际癌症研究中心的数据[2]显示,我国癌症的发病率和死亡率均呈逐渐上升趋势,高于世界平均水平,且大部分癌症患者确诊时已为晚期。晚期癌症患者由于肿瘤分期较晚,病情危重,疾病进展风险显著增高,同时面临放化疗相关毒性反应、社会经济负担及严重心理困扰等多重压力,使其在生理、心理及精神层面承受巨大痛苦。在此背景下,提升患者终末期生存质量、缓解其多维痛苦已成为晚期癌症照护的核心目标[3]。沟通是每个家庭单位不可缺少的基础部分,家庭沟通是指家庭成员在压力情况下沟通和表达想法和感受的能力[4]。研究[5]表明,晚期癌症的确诊会破坏其家庭功能,影响其家庭沟通水平,而家庭沟通不畅也会增加晚期癌症患者和家庭照护者的抑郁、焦虑情绪以及降低彼此关系满意度。目前,国内研究主要集中于癌症患者及其配偶沟通方面,现有的家庭回避癌症沟通量表虽能够达到评估家庭沟通水平的目的,但其主要关注家庭沟通的开放程度及回避程度,并不涵盖晚期癌症患者与家庭照顾者之间的沟通一致性和特异性[6],而癌症患者家庭沟通量表(the cancer communication assessment tool for patients and families,CCAT-PF)[7]在国外已被证实对于癌症患者及其家庭照顾者家庭沟通现状的评估具有特异性,但此工具在国内鲜有应用。因此,本研究旨在分析处于晚期癌症患者与家庭照顾者的家庭沟通现状,并分析其影响因素,以期为晚期癌症患者家庭制定个性化家庭沟通实践方案以及提高其生命质量提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样法,于 2023 年 9 月—2024 年 6 月选取安徽省某 2 所三级甲等综合医院的住院晚期癌症患者作为研究对象。纳入标准:(1)年龄≥18 岁;(3)临床病理分期为癌症Ⅲ或Ⅳ期;(3)经临床医生根据相关生存分析评估工具[8]评估预计生存时间为 3 ~ 6 个月;(4)获得知情同意参与本研究,且能够理解和独立完成调查问卷。排除标准:(1)既往患有精神疾病者;(2)存在沟通障碍或不能准确理解量表者;(3)病情危重不能配合者;(4)参与过类似研究者。logistic 回归分析中样本量应为自变量数目的 5 ~ 10 倍[9],本研究共 18 个自变量,考虑 20% 的无效应答,样本量应为 108 ~ 216。本研究已获得医院伦理委员会批准[审批号:(2023)伦审研第 (91)号]。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表 由研究者基于文献回顾以及小组讨论进行自行设计。社会人口学资料包括:年龄、性别、宗教信仰、户籍所在地、医保类型、癌症类型、放疗史、化疗史、慢性病史、婚姻状态、文化程度、家庭人均月收入、确诊时长、职业状态、Charlson 共病指数评分(Charlson co-morbidity index,CCI)[10]。

1.2.2 CCAT-PF 量表由美国学者 Siminoff 等[7]于 2008 年编制而成,量表最初为 30 个条目,内部一致性信度为 0.94,后修订为 18 个条目。中文版 CCAT-PF[11]包括癌症患者家庭沟通量表-患者版本(the cancer communication assessment tool for patients and families-patients,CCAT-P)和癌症患者家庭沟通量表-家庭照顾者版本(the cancer communication assessment tool for patients and families-families,CCAT-F)2 个分量表,每个分量表各包含 4 个维度和 17 个条目,其中条目 2、5 ~ 7、11 ~ 17 为反向计分。量表可以单独发放调查,也可同时发放调查,本研究采用的是 CCAT-P 单独调查。量表总分为 17 ~ 102 分,其中 17 ~ 51 分为家庭沟通良好,52 ~ 102 分为家庭沟通障碍,量表得分越高代表患者和家庭照顾者之间的沟通障碍越大。该量表在本研究中的 Cronbach′s α 系数为 0.902,具备良好的信效度。

1.2.3 家庭功能评估量表(the adaptation partnership growth affection and resolve,APGAR) 量表由 Smilkstein 等[12]学者于 1978 年编制,用于评估青少年及其以上人群对其感知的家庭功能水平的满意度,吕繁等[13]学者于 1999 年对其进行汉化。该量表包括适应度、合作度、成长度、情感度、亲密度 5 个维度。量表总分为 0 ~ 10 分,其中 0 ~ 6 分为家庭功能障碍,7 ~ 10 分为家庭功能良好。该量表在本研究中的 Cronbach′s α 系数为 0.962,具备良好的信效度。

1.2.4 恐惧疾病进展简化量表(fear of progression questionnaire-short form,FoP-Q-SF) 量表由 Mehnert 等[14]于 2006 年编制而成,用于评估乳腺癌患者的疾病恐惧程度,量表总 Cronbach′s α 系数为 0.87。吴奇云等[15]于 2015 年进行汉化,用于评估原发性肝癌患者的恐惧疾病程度 ,该量表包括生理健康和社会家庭 2 个维度,共 12 个条目。量表总分为 12 ~ 60 分,总分越高表明恐惧疾病进展心理程度越高。该量表在本研究中的 Cronbach′s α 系数为 0.883,具备良好的信效度。

1.2.5 癌症患者社会疏离量表(social isolation assessment questionnaire for cancer patients,SIAQ-CP)

中国知网 https://www.cnki.net

量表由苏闪闪等[16]于 2023 年编制而成,用于测评癌症患者社会疏离水平,量表包括自我隔离、孤独感、疏远感和无意义感 4 个维度,共 17 个条目,总分为 17 ~ 85 分,分数越高表示社会疏离水平越高。该量表在本研究中的 Cronbach's α 系数为 0.902,具备良好的信效度。

1.3　资料收集方法　本研究采用现场发放纸质问卷填写以及线上扫码填写电子版的双重方式进行数据收集。由经过系统培训的调查员向符合条件的研究对象发放纸质版问卷,并提供一对一指导,确保问卷填写准确完整。对于低教育水平或视力障碍的患者,调查员采用问答形式协助其完成问卷。问卷当场回收并进行完整性核查,如有缺项或漏项,及时进行补充。本研究共发放问卷 210 份,回收有效问卷 200 份,有效回收率 95.24%。

1.4　统计学方法　采用 SPSS 27.0 软件进行资料录入和统计分析。计量资料符合正态分布,则使用($\bar{x} \pm s$)对数据进行描述,组间比较采用独立样本 t 检验;不符合正态分布的采用 $M(P_{25}, P_{75})$ 表示,组间比较采用 Mann-Whitney U 检验。计数资料使用频数、百分率进行描述,组间比较采用 χ^2 检验。筛选单因素方差分析有统计学意义的预测变量,继而构建 logistic 回归模型分析并识别独立影响因素。$P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　晚期癌症患者一般资料及家庭沟通的单因素分析　本研究共纳入 200 例晚期癌症患者,其中男性 107 例(54.9%),女性 93 例(45.1%),年龄 23 ~ 82 岁,平均年龄为(54.72 ± 7.72)岁。CCAT-P 得分为 53.08(25.00. 97.00)分,其中家庭沟通良好 92 例(46.0%),家庭沟通障碍 108 例(54.0%)。结果显示,婚姻状态、文化程度、确诊时长、家庭人均月收入、职业状态、CCI、APGAR、FoP-Q-SF、SIAQ-CP 等得分比较,见表 1。

表 1　晚期癌症患者一般资料及家庭沟通的单因素分析($n = 200$)

项目	分类	家庭沟通良好($n = 92$)	家庭沟通障碍($n = 108$)	统计值	P
年龄[岁,$M(P_{25}, P_{75})$]		45.00(41.00,50.00)	64.00(61.00,70.00)	1.578*	0.061
性别[例(百分率,%)]	男	41(44.57)	66(61.11)	1.425	0.166
	女	51(55.43)	42(38.89)		
宗教信仰[例(百分率,%)]	有	9(9.80)	6(5.56)	0.721	0.324
	无	83(90.20)	102(94.44)		
户籍所在地[例(百分率,%)]	城镇	58(63.04)	34(31.48)	1.051	0.331
	农村	34(36.96)	74(68.52)		
医保类型[例(百分率,%)]	新农合	25(27.17)	41(37.96)	0.836	0.476
	居民医保	20(21.74)	19(17.59)		
	职工医保	20(21.74)	11(10.19)		
	商业医保	18(19.57)	20(18.51)		
	自费	9(9.78)	17(15.75)		
癌症类型[例(百分率,%)]	肺癌	32(34.78)	18(16.67)	1.942	0.065
	胃癌	15(16.30)	13(12.03)		
	肠癌	10(10.86)	11(10.19)		
	肝癌	13(14.13)	17(15.74)		
	肾癌	11(11.96)	17(15.74)		
	乳腺癌	5(5.44)	13(12.04)		
	宫颈癌	5(5.44)	16(14.81)		
	其它癌症	1(1.09)	3(2.78)		
化疗史[例(百分率,%)]	是	43(46.74)	67(62.04)	1.643	0.052
	否	49(53.26)	41(37.96)		
放疗史[例(百分率,%)]	是	50(54.35)	39(36.11)	1.543	0.061
	否	42(45.65)	69(63.89)		
慢性病史[例(百分率,%)]	是	40(43.48)	66(61.11)	1.546	0.059
	否	52(56.52)	42(38.89)		
婚姻状态[例(百分率,%)]	在婚	60(65.22)	67(62.04)	15.200	<0.001
	非在婚	32(34.78)	41(37.96)		

中国知网　https://www.cnki.net

续表 1 晚期癌症患者一般资料及家庭沟通的单因素分析($n=200$)

项目	分类	家庭沟通良好($n=92$)	家庭沟通障碍($n=108$)	统计值	P
文化程度[例(百分率,%)]	小学及以下	21(22.83)	40(37.04)	34.425	<0.001
	初中	43(46.74)	40(37.04)		
	高中	19(20.65)	17(15.74)		
	大专及以上	9(9.78)	11(10.18)		
家庭人均月收入[例(百分率,%)]	0 ~ <2 000 元	26(28.26)	36(33.33)	27.046	<0.001
	2 000 ~ <4 000 元	17(18.48)	20(18.52)		
	4 000 ~ <6 000 元	17(18.48)	20(18.52)		
	6 000 ~ <8 000 元	16(17.39)	15(13.89)		
	8 000 ~10 000 元	9(9.78)	9(8.33)		
	>10 000 元	7(7.61)	8(7.41)		
确诊时长[例(百分率,%)]	<1 年	52(56.52)	27(25.00)	25.134	<0.001
	≥1 年	40(43.48)	81(75.00)		
职业状态[例(百分率,%)]	在职	41(44.57)	11(10.19)	27.153	<0.001
	非在职	51(55.43)	97(89.81)		
CCI 得分(分,$\bar{x}\pm s$)		3.14 ±1.08	4.80 ±1.32	5.448#	<0.001
APGAR 得分(分,$\bar{x}\pm s$)		7.24 ±1.78	4.97 ±1.09	69.540#	<0.001
FoP-Q-SF 得分(分,$\bar{x}\pm s$)		30.80 ±9.16	43.58 ±6.38	88.347#	<0.001
SIAQ-CP 得分(分,$\bar{x}\pm s$)		43.23 ±2.86	57.35 ±1.83	49.254#	<0.001

注:统计值中,* 为 Z 值,# 为 t 值,其余为 χ^2 值。

2.2 晚期癌症患者家庭沟通的多因素分析 以是否发生家庭沟通障碍为因变量,以单因素分析有统计学意义的自变量纳入回归方程。其中 CCI、APGAR、FoP-Q-SF、SIAQ-CP 得分以原值带入,其余自变量赋值见表 2。logistic 回归分析结果显示文化程度、家庭人均月收入、确诊时长、家庭功能、恐惧疾病进展、社会疏离是影响晚期癌症患者家庭沟通的独立影响因素,见表 3。

表 2 自变量赋值情况

自变量	赋值方式
文化程度	大专及以上 =0;高中 =1;初中 =2;小学及以下 =3
确诊时长	<1 年 =0;≥1 年 =1
职业状态	在职 =0;非在职 =1
婚姻状态	在婚 =0;非在婚 =1
家庭人均月收入	>10 000 元 =0;8 000 ~10 000 元 =1;6 000 ~ <8 000元 =2;4 000 ~ <6 000 元 =3;2 000 ~ <4 000 =4;0 ~ <2 000 元 =5

表 3 晚期癌症患者家庭沟通的 logistic 回归分析

项目	β	SE	Wald χ^2	OR(95% CI)	P
常量	-5.148	1.912	7.254	—	0.007
文化程度	-0.720	0.312	5.328	0.487(0.264 ~0.898)	0.021
家庭人均月收入	0.621	0.210	8.742	1.861(1.234 ~2.807)	0.003
确诊时长	1.032	0.504	4.192	2.807(1.045 ~1.541)	0.041
APGAR 得分	1.104	0.459	5.782	3.017(1.227 ~2.419)	0.016
FoP-Q-SF 得分	0.873	0.342	6.521	2.394(1.225 ~1.678)	0.011
SIAQ-CP 得分	1.642	0.510	10.362	5.167(1.902 ~4.035)	0.001

注:仅显示差异有统计学意义的变量。

3 讨论

3.1 晚期癌症患者家庭沟通处于不良状态 本研究结果显示,晚期癌症患者家庭沟通的得分为 53.08(25.00,97.00)分,处于家庭沟通障碍状态,该分数高于德国学者 Michael 等[17]及美国学者 Siminoff 等[18]的研究结果。可能原因是中西方文化存在差异,双方在沟通方式、情感表达及家庭关系等方面存在一定区别,直接导致了晚期癌症患者家庭沟通现况呈现不同特征;相较于西方文化中鼓励的开放式沟通,中国家庭更倾向于含蓄、保守的沟通方式,易导致疾病信息传递不全,加剧患者孤独感及家庭误解,从而提升沟通障碍风险[19]。本研究纳入的晚期癌症患者平均年龄为(54.72 ±7.72)岁,涵盖肺癌、胃癌、乳腺癌等多

中国知网 https://www.cnki.net

种癌症类型。中老年患者因躯体功能衰退、认知灵活性下降及社会心理压力增大,更易出现沟通困难。此外,不同癌症类型对家庭功能的影响也具有异质性,如乳腺癌患者可能因身体意象改变产生社交回避,消化道癌症患者则可能因疼痛症状导致沟通意愿下降[17]。因此,针对不同年龄段和不同病种的晚期癌症患者,建议临床医护人员可以实施个体化家庭沟通干预方式,如加强对晚期癌症患者和家属相关疾病知识的普及,也可以引入“叙事护理”的心理护理干预方式,通过挖掘和分享患者背后的故事来提升晚期癌症患者家庭共情能力,帮助他们了解疾病进程和治疗方案,减轻疾病带来的焦虑和压力,为晚期癌症患者创造更有利的家庭沟通环境。

3.2　晚期癌症患者家庭沟通的影响因素

3.2.1　文化程度　本研究结果显示,文化程度低是发生晚期癌症患者家庭沟通障碍的独立危险因素($P<0.05$),此结果与李思等[20]研究结果一致。原因可能是低文化程度患者受限于词汇储备与表达能力,低文化水平患者由于语言表达和理解能力有限,易出现沟通自我效能低下,被动接受家属决策,形成家属主导和患者顺从的单向沟通模式,削弱了癌症患者在沟通中的主体性[19]。同时,此类家庭整体健康素养较低,双方在疾病认知和情绪解读上存在显著偏差,进一步降低了沟通效率[21]。因此,针对低文化程度的晚期癌症患者家庭,临床医护人员可以设计图文手册、动画短视频等视觉化辅助工具,将复杂的疾病知识转化为通俗内容,降低文化程度较低患者的信息理解门槛;另一方面,可联合社区卫生服务中心开展家庭健康沟通工作坊,通过角色扮演、案例模拟等互动形式,鼓励患者表达自身需求。此外,在日常诊疗中,医护人员可以适量增加与低文化程度患者家庭的沟通时长,确保信息传递到位,从临床干预层面帮助此类家庭构建更高效的沟通模式,进而改善其家庭沟通水平。

3.2.2　家庭人均月收入　本研究结果显示,家庭人均月收入较低是发生晚期癌症患者家庭沟通障碍的独立危险因素($P<0.05$),此结果与李思等[20]研究结果一致。原因可能是晚期癌症患者的家庭人均月收入能够直接决定医疗费用的负担能力。相关研究[22]表明,经济压力每增加 1 个单位,家庭冲突风险上升 27%,经济拮据迫使患者家庭会优先讨论治疗费用而非情感需求,易引发“工具性沟通主导”现象。低收入癌症患者家庭往往面临着沉重的经济负担,长期经济压力会加剧家属焦虑水平,减少对癌症患者家庭共情性回应,容易导致患者和家属产生焦虑、抑郁等负面情绪,进而影响沟通意愿和能力。同时,低收入家庭可能难以获得高质量的医疗资源和社会支持,导致沟通问题无法得到及时有效的解决[23]。因此,医护人员可以多关注并整合医保政策宣教与心理疏导,建立“经济 - 心理”双重支持通道,为低收入晚期癌症患者家庭的经济状况和心理社会需求提供力所能及的支持和帮助,以改善低收入晚期癌症患者家庭沟通状况。

3.2.3　确诊时长　本研究结果显示,确诊时长≥1 年是发生晚期癌症患者家庭沟通障碍的独立危险因素($P<0.05$),此结果与李萌萌[24]的研究结果一致。原因可能是晚期癌症患者家庭长期处于疾病监测、治疗配合与照护协调的持续压力状态,易导致癌症患者家庭成员诱发情感麻木与沟通回避等不良心理反应,削弱家庭成员主动发起有效沟通的意愿[25]。相关研究[23]表明,在癌症确诊 12 个月后,家庭照顾者与患者的积极沟通频率较疾病初期下降 43%。此外,确诊时长越长,因长期疾病带来的身体病痛、治疗副作用及经济负担会逐步消耗家庭成员的心理资源,易引起情绪耗竭与沟通疲劳,会显著影响癌症患者家庭沟通质量[26]。因此,针对确诊时间较长的晚期癌症患者家庭,建议医护人员建立分阶段、动态化的沟通支持机制,如在病程初期,医护人员可侧重于疾病知识与治疗方案的共享,通过定期健康宣教帮助家庭建立对疾病的科学认知;病程中后期,可引入结构化家庭会议模式,由医护人员或心理咨询师主持,引导患者与家属共同梳理阶段性照护需求、并定期评估家庭沟通需求的变化。同时,需进一步强化社会支持网络建设,如线上照护经验交流平台,为长期处于照护状态的晚期癌症患者家庭提供情感支持与经验借鉴渠道,通过缓解疾病压力与焦虑情绪,为晚期癌症患者家庭的有效沟通创造积极氛围,最终改善晚期癌症患者家庭的沟通质量。

3.2.4　家庭功能　本研究结果显示,家庭功能障碍是发生晚期癌症患者家庭沟通障碍的独立危险因素($P<0.05$),此结果与范廷婷等[27]研究结果一致。原因可能是功能失调家庭相应缺乏应对疾病危机的弹性策略,常以指责或沉默替代问题解决,从而影响家庭沟通质量。相关研究[28]表明,家庭功能得分低的癌症患者家庭的冲突解决效率仅为高分家庭的 31%,家庭功能障碍也会导致家庭成员之间缺乏相互支持和凝聚力,无法形成有效应对疾病的合力,患者可能会感到孤立无援,家属也会感到身心俱疲。同

中国知网　https://www.cnki.net

时,家庭功能障碍容易导致家庭成员之间关系紧张、冲突频繁,造成双方情绪困扰和心理压力,进一步影响家庭沟通意愿[25]。因此,建议临床医护人员可针对存在家庭功障碍的癌症患者家庭提供专业的家庭治疗,如鼓励癌症患者参加癌友俱乐部类似活动,也可以利用有效的干预方案帮助癌症患者家庭成员之间识别并改变不良的沟通模式,建立有效的沟通机制,促进癌症患者家庭成员相互理解和支持,以此改善癌症患者的家庭功能,提高家庭成员之间的沟通质量。

3.2.5 恐惧疾病进展 本研究结果显示,高水平恐惧疾病进展心理是发生晚期癌症患者家庭沟通障碍的独立危险因素($P<0.05$),此结果与 Sood 等[25]研究结果一致。原因可能是高水平恐惧疾病进展心理状态的晚期癌症患者家庭会倾向于过度关注疾病恶化的信息,更容易产生灾难化思维,阻碍癌症患者家庭共同决策行为。研究[25]显示,恐惧疾病进展评分每增加 5 分,家庭回避沟通行为风险上升 1.8 倍。癌症患者的恐惧疾病心理具有显著的家庭扩散性,会直接传递给家庭照顾者,进而影响家庭成员之间的沟通模式和质量,显著破坏晚期癌症患者家庭成员间在沟通模式完整性与互动质量。因此,建议医护人员应将恐惧疾病进展水平纳入晚期癌症患者的常规心理评估指标,通过结构化访谈或标准化量表动态监测癌症患者情绪变化,结合医患沟通强化疾病信息透明化;其次,可引入认知行为疗法,帮助晚期癌症患者重构对疾病的理性认知,降低灾难化思维发生频率;最后,联合家庭情绪聚焦治疗,指导晚期癌症患者家庭成员学习情绪识别与共情回应技巧,阻断负性情绪在家庭内部的传递链条,促进晚期癌症患者与家庭照顾者在治疗、照护等关键问题上的有效沟通,逐步改善晚期癌症患者家庭沟通质量。

3.2.6 社会疏离 本研究结果显示,高水平社会疏离心理是发生晚期癌症患者家庭沟通障碍的独立危险因素($P<0.05$),此结果与 Liu 等[29]的研究结果一致。原因可能是晚期癌症患者因肿瘤进展引发持续性躯体疼痛、治疗相关疲劳及生活自理能力下降,此类身心双重应激易导致其情感感知敏感度降低,进而在家庭互动中出现情感回应延迟或家庭沟通障碍。相关研究[30]表明,61% 的健康人群在社交场景中会因对癌症的恐惧或认知偏差,主动回避癌症患者及其家属,这种外部社会支持的缺失会强化患者的被孤立感,促使其进一步收缩社交与家庭沟通边界。此外,晚期癌症患者长期受沮丧、绝望等负性情绪影响,更倾向于减少疾病相关沟通以规避情绪冲突,加剧沟通障碍[31]。因此,建议临床医护人员将癌症患者社会疏离量表相关评估工具纳入晚期癌症患者入院常规心理评估体系范畴,通过量化评分精准识别高风险家庭,并及时提供个体化心理支持和疏导,帮助晚期癌症患者克服负面情绪重建社会价值与认同感;此外,开展家庭沟通技能科普小讲座,指导家属运用积极倾听与共情回应技巧,打破晚期癌症患者自我封闭壁垒,在满足癌症患者生理照护需求的同时,修复家庭沟通功能,提高晚期癌症患者生命质量。

4 小结

本研究结果显示,晚期癌症患者家庭普遍处于沟通不良状态,文化程度、家庭人均月收入、确诊时长、家庭功能、恐惧疾病进展、患者社会疏离均是影响晚期癌症患者家庭沟通水平的独立影响因素。临床医护人员可采取以下策略:(1)运用具有良好特异性的标准化评估工具精准识别存在家庭沟通障碍高风险的晚期癌症患者家庭。(2)积极探索数字化工具在支持家庭沟通中的应用潜力,以突破地域和资源限制,实现及时、个性化的临床干预。针对不同患者特征与需求,建议提供文化适应性强的沟通技巧培训、心理与社会支持等综合措施。(3)建立由安宁疗护专科护士主导的结构化临终沟通模型,联合心理咨询师、临床医护人员定期组织家庭会议,聚焦于疾病信息共享、情绪管理及预立医疗照护计划讨论,旨在系统性地提升晚期癌症患者家庭沟通质量与水平。本研究局限性为横断面设计,样本仅来源于 2 所三甲医院,未来研究需通过多中心、大样本的纵向追踪,以揭示家庭沟通水平的动态演变规律。其次,本研究仅采用 CCAT-P 进行单主体评估,未同步纳入家庭照顾者视角,可能导致对沟通一致性的评估不够全面。建议后续研究结合双主体数据进行评估,为有效提升晚期癌症患者家庭沟通水平提供更坚实的理论依据。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] 温华. 晚期癌症患者家庭照顾者准备度现状及其干预研究[D]. 郑州:郑州大学,2021.

[2] 曹毛毛,陈万青. GLOBOCAN 2020 全球癌症统计数据解读[J]. 中国医学前沿杂志(电子版),2021,13(3):63-69.

[3] 林海洋,黎玉梅,郝燕萍. 照护目标沟通在癌症患者临床应用中的研究进展[J]. 医学与哲学,2023,44(14):42-47.

中国知网 https://www.cnki.net

[4] 马瑞瑞,马红梅. 临终沟通辅助工具的研究进展[J]. 护理研究,2023,37(8):1420-1425.

[5] JEONG A,SHIN D W,KIM S Y,et al. Avoidance of cancer communication,perceived social support,and anxiety and depression among patients with cancer[J]. Psychooncology,2016,25(11):1301-1307.

[6] LIU H,LIUX,LIU Z,et al. Death anxiety and its relationship with family function and meaning in life in patients with advanced cancer:a cross-sectional survey in China[J]. Asia Pac J Oncol Nurs,2022,9(10):100134.

[7] SIMINOFFL A,ZYZANKI S J,ROSEJ H,et al. The cancer communication assessment tool for patients and families (CCAT-PF):a new measure[J]. Psycho-oncology,2008,17(12):1216-1224.

[8] 张利娜,曹亚军,王翠霞,等. 社区安宁疗护应用姑息预后指数对患者生存分析的研究[J]. 山西医药杂志,2023,52(13):988-992.

[9] 邱皓政. 量化研究与统计分析:SPSS 中文视窗版数据分析范例解析[M]. 重庆:重庆大学出版社,2009.

[10] BANNAY A,CHAIGNOT C,BLOTIERE P O,et al. The best use of the charlson comorbidity index with electronic health care database to predict mortality[J]. Med Care,2016,54(2):188-194.

[11] 马瑞瑞,马红梅,陈炜琳,等. 癌症患者家庭沟通量表的汉化及信效度检验[J]. 护士进修杂志,2024,39(4):378-384.

[12] SMILKSTEIN G. The family APGAR:a proposal for a family function test and its use by physicians[J]. J Fam Pract,1978,6(6):1231-1239.

[13] 吕繁,曾光,刘松暖,等. 家庭关怀度指数问卷测量脑血管病病人家庭功能的信度和效度研究[J]. 中国公共卫生,1999(11):27-28.

[14] MEHNERT A,HERSCHBACH P,BERG P,et al. Fear of progression in breast cancer patients-validation of the short form of the Fear of Progression Questionnaire (FoP-Q-SF)[J]. Z Psychosom Med Psychother,2006,52(3):274-288.

[15] 吴奇云,叶志霞,李丽,等. 癌症患者恐惧疾病进展简化量表的汉化及信效度分析[J]. 中华护理杂志,2015,50(12):1515-1519.

[16] 苏闪闪,董又鸣,郑蔚,等. 癌症患者社会疏离测评问卷的编制及信效度检验[J]. 护理学报,2023,30(17):51-56.

[17] MICHAEL N,GORELIK A,GEORGOUSOPOULOU E,et al. Patient-caregiver communication concordance in cancer-refinement of the cancer communication assessment tool in an australian sample[J]. Support Care Cancer,2022,30(9):7387-7396.

[18] SIMINOFF L A,WILSON-GENDERSON M,BARTA S,et al. Hematological cancer patient-caregiver dyadic communication:a longitudinal examination of cancer communication concordance[J]. Psychooncology,2020,29(10):1571-1578.

[19] 成香,杜若飞,周会月,等. 结直肠癌造口患者夫妻疾病沟通现状及影响因素[J]. 护理学杂志,2021,36(1):10-13.

[20] 李思. 青年女性癌症病人夫妻疾病沟通及自我倡权现状[J]. 护理研究,2022,36(19):3522-3527.

[21] HARDING R,SALINS N,SHARAN K,et al. Health literacy in communication,decision-making and outcomes among cancer patients,their families and clinicians in India:a multicentre cross-sectional qualitative study[J]. Psycho-Oncology,2022,31(3):532-540.

[22] 郑萍,付菊芳,王波,等. 243 例乳腺癌患者配偶照顾负担及影响因素研究[J]. 中华护理杂志,2013,48(08):718-721.

[23] ELAINE W B,HALEY B,BETTY F,et al. Understanding family caregiver communication to provide family-centered cancer care[J]. Seminars in oncology nursing,2017(5):507-516.

[24] 李萌萌. 家庭韧性问卷汉化及其在乳腺癌患者中的应用研究[D]. 郑州:郑州大学,2021.

[25] SOOD A K,LUTGENDORF S K,STEVEN C W. CHAPTER 11-neuroendocrine regulation of cancer progression: i. biological mechanisms and clinical relevance[J]. Psychoneuroimmunology (Fourth Edition),2007,1:233-249.

[26] FISHER C L,NUSSBAUM J F. The influence of family communication patterns on the processing of messages to increase family health history seeking intentions[J]. Health Communication,2021,36(4):424-432.

[27] 范廷婷,钟梦诗,罗彩凤,等. 乳腺癌术后患者心理弹性和积极应对方式对自我形象的影响研究[J]. 护士进修杂志,2019,34(2):122-125.

[28] LIM J W,ASHING-GIWA K T. Is family functioning and communication associated with health-related quality of life for Chinese- and Korean-American breast cancer survivors? [J]. Qual Life Res,2013,22(6):1319-1329.

[29] LIU X,WEN S,WU D. The mediating roles of family care and self-efficacy between stigma and social alienation among colorectal cancer survivors[J]. Scientific Reports,2025,15(1):15312.

[30] 王硕,吕利明,刘培培,等. 乳腺癌幸存者社会疏离的研究进展[J]. 护理学杂志,2020,35(9):108-112.

[31] 何青林. 卵巢癌患者社会疏离与疾病感知及应对方式的关系研究[D]. 开封:河南大学,2023.

(修回日期:2025-04-10)

(本文编辑:刘顺芳　陈幸)

中国知网　https://www.cnki.net